

TEMA 5.14 • HEMATOLOGÍA

Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT)

PERFIL EUNACOM 1.07.2.004
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT) y Síndrome Hemolítico-Urémico (SHU)

Microangiopatías Trombóticas — Concepto

Obstrucción de microcirculación por trombos de plaquetas/fibrina → hemólisis mecánica + trombocitopenia + isquemia orgánica.

PTT

- **Mecanismo:** déficit o anticuerpos contra **ADAMTS13** (proteasa que escinde el FvW) → trombos de FvW masivos
- **Afecta principalmente:** SNC + riñón + corazón
- **Clínica:**
 - - **Anemia: Generalidades**|Anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos en frotis)
 - - Trombocitopenia
 - - Compromiso neurológico (confusión, convulsiones, coma)
 - - Falla renal aguda
- **Diagnóstico:** ADAMTS13 < 10% + anticuerpos inhibidores

Tratamiento

1. **Plasmaféresis urgente** (de elección — reemplaza el ADAMTS13)
2. Corticoides EV + Rituximab (control de la autoinmunidad)

SHU (Síndrome Hemolítico-Urémico)

- Más frecuente en **niños**
- **Causa:** diarrea por *E. coli* O157:H7 → toxina Shiga → daño endotelial renal
- **Tríada: anemia hemolítica** + trombocitopenia + **falla renal aguda** (predomina sobre SNC)
- **Tratamiento:** soporte + diálisis si necesario; evitar antibióticos (pueden liberar más toxina)

Síndrome HELLP

- Complicación grave del embarazo (3er trimestre)
- **Tríada:** Hemólisis + Elevación enzimas hepáticas + Low platelets (plaquetas bajas)
- Tratamiento: **parto** (resolución definitiva) + corticoides si viable

Comparación

TABLA 5.14.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS			
	PTT	SHU	HELLP
Edad	Adulto joven	Niños	Embarazo
Órgano principal	SNC	Riñón	Hígado
Precipitante	Autoinmune	Diarrea E. coli	Embarazo

| Tratamiento | **Plasmaféresis** | Soporte + diálisis | **Parto** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Mujer de 28 años, previamente sana, que presenta anemia hemolítica con esquistocitos en el frotis, trombocitopenia, compromiso de conciencia y falla renal aguda de rápida instalación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La PTT es una microangiopatía potencialmente mortal que se agrava muy rápidamente
- Más frecuente en adultos jóvenes, mujeres y embarazadas
- Clínica: anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia + afectación SNC + falla renal aguda
- En frotis: esquistocitos y fragmentocitos (anemia hemolítica microangiopática)
- Diagnóstico diferencial: SHU (niños, post-diarrea), HELLP (embarazo, daño hepático)
- Tratamiento urgente: plasmaféresis (recambio de plasma)
- Tratamiento a mediano plazo: corticoides EV y rituximab
- ADAMTS13 <10% + inhibidor confirma el diagnóstico, pero suele llegar tarde: tratar antes de confirmar

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT))**PREGUNTA 1**

Mujer de 28 años, previamente sana, que presenta anemia hemolítica con esquistocitos en el frotis, trombocitopenia, compromiso de conciencia y falla renal aguda de rápida instalación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** PTI aguda
- B)** Púrpura trombocitopénica trombótica
- C)** Síndrome hemolítico urémico
- D)** CID
- E)** Anemia hemolítica autoinmune

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de emergencia en la púrpura trombocitopénica trombótica?

- A)** Corticoides endovenosos
- B)** IgG endovenosa
- C)** Recambio de plasma (plasmaféresis) urgente
- D)** Esplenectomía de urgencia
- E)** Transfusión de plaquetas

PREGUNTA 3

¿Cuál es el examen confirmatorio de la PTT?

- A)** Prueba de Coombs directa
- B)** Biopsia de médula ósea
- C)** ADAMTS13 con actividad <10% más presencia de inhibidor
- D)** Electroforesis de hemoglobina
- E)** Dímero D elevado

RESUMEN: PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT)

Esta clase aborda la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), una microangiopatía potencialmente mortal que afecta más frecuentemente a adultos jóvenes, especialmente mujeres y embarazadas. Puede confundirse con SHU en niños y con síndrome de HELLP en el embarazo. La clínica incluye anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos en frotis) con trombocitopenia, afectación del SNC (compromiso de conciencia, coma, convulsiones, parestesias migratorias) y falla renal aguda. La enfermedad progresa muy rápidamente. El tratamiento es urgente: recambio plasmático (plasmaféresis) de emergencia, seguido de corticoides EV y rituximab a mediano-largo plazo. El diagnóstico confirmatorio (ADAMTS13 <10% + inhibidor/anticuerpo) suele llegar tarde, por lo que se trata antes de confirmarlo basándose en la clínica y los hallazgos de laboratorio.